Клинические рекомендации

Туберкулёз у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A15** — Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически **A16** — Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически **A17** — Туберкулез нервной системы **A18** — Туберкулез других органов **A19** — Милиарный туберкулез
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров «Ассоциация фтизиатров»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/507_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Туберкулёз периферических лимфатических узлов 2

3. Диагностика 2

3.1 Консультация оториноларинголога и аудиометрия 2

4. Лечение 3

4.1 Химиотерапия лекарственно-чувствительного туберкулёза 3

4.2 Ототоксичность и вестибулотоксичность 3

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 3

5.1 Показания к госпитализации 3

6. Источник и актуальность 3

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 4

1. Основные положения

- Туберкулёз — инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза; могут быть поражены любые органы и ткани. Туберкулёз периферических лимфатических узлов у детей сопровождается увеличением чаще всего шейных и надключичных узлов с одной стороны.
- Детям со сниженным слухом и перенесённым отитом в анамнезе перед включением в схему инъекционных препаратов показан осмотр оториноларинголога с тональной и/или речевой аудиометрией: при выявленной патологии аминогликозиды и капреомицин не назначают.
- При ранних признаках ототоксичности — снижении порога **на 25 дБ и более на двух смежных частотах**, преходящем шуме или заложенности в ушах — амикацин, канамицин, стрептомицин заменяют или переводят на интермиттирующий режим; при сохранении нарушений препарат отменяют.
- Госпитализации в туберкулёзную больницу подлежат дети с активным туберкулёзом любой локализации в фазу интенсивной терапии, с бактериовыделением, с лекарственно-устойчивыми, распространёнными и осложнёнными формами.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Туберкулёз — инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis complex), при котором могут быть поражены любые органы и ткани человеческого тела (кроме волос и ногтей).

2.2 Туберкулёз периферических лимфатических узлов

Сопровождается увеличением чаще всего шейных, надключичных лимфатических узлов с одной стороны. Может протекать бессимптомно, с постепенным нарастанием казеозного некроза в строме узла.

По мере прогрессирования

1. симптомы интоксикации;
2. кожа над узлом гиперемирована, истончена, появляется флюктуация, образуется абсцесс;
3. в 10% случаев — прорыв казеозно-некротических масс с образованием свищей с густым серовато-белым гноем без запаха.

При неполном опорожнении узлов заболевание приобретает хроническое течение с обострениями. Увеличение периферических узлов может быть проявлением микобактериоза — заболевания, вызванного нетуберкулёзными микобактериями, особенно при ВИЧ-инфекции.

3. Диагностика

3.1 Консультация оториноларинголога и аудиометрия

Детям с жалобами на снижение слуха и перенесённым отитом в анамнезе перед включением в схему химиотерапии инъекционных препаратов показан осмотр оториноларинголога с тональной и/или речевой аудиометрией — для решения, можно ли их назначать.

Речевая аудиометрия показана всем пациентам с нарушением слуха и заболеваниями органов слуха перед включением аминогликозидов (амикацин, канамицин) и полипептидов (капреомицин): эти препараты могут вызывать снижение слуха. При выявленной патологии инъекционные препараты в схему не включают.

4. Лечение

4.1 Химиотерапия лекарственно-чувствительного туберкулёза

При 6-месячном режиме в фазу интенсивной терапии (**2 мес**) применяется комбинация из четырёх препаратов: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол; дозы — по возрасту и массе тела.

4.2 Ототоксичность и вестибулотоксичность

Наблюдение при лечении канамицином и амикацином

1. **ототоксичность** — оценка жалоб на шум в ушах, снижение слуха; речевая аудиометрия ежемесячно
2. **вестибулотоксичность** — оценка жалоб на головокружение, неустойчивость, тошноту, рвоту; выявление нистагма

Тактика при снижении слуха

1. осмотр оториноларинголога;
2. симптоматическая терапия;
3. тональная аудиометрия;
4. при ранних симптомах (снижение порога **на 25 дБ и более на двух смежных частотах**, преходящий шум или заложенность в ушах) — замена амикацина, канамицина, стрептомицина на капреомицин при сохранённой чувствительности или интермиттирующий режим (3 раза в неделю);
5. при сохранении или нарастании нарушений — отмена препарата.

Тактика при вестибулотоксичности

1. при ранних симптомах (преходящее головокружение, ощущение «заложенности» в ушах) — снижение дозы или интермиттирующий режим (3 раза в неделю);
2. осмотр оториноларинголога;
3. симптоматическая терапия;
4. при сохранении или нарастании нарушений — отмена препарата.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации в туберкулёзную больницу

1. активный туберкулёз любой локализации для лечения в фазу интенсивной терапии;
2. туберкулёз органов дыхания с бактериовыделением;
3. лекарственно-устойчивый туберкулёз (установленный или предполагаемый);
4. распространённые, деструктивные, осложнённые формы;
5. жизнеугрожающие осложнения, в том числе кровохарканье;
6. необходимость специальных, в том числе хирургических, методов диагностики.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Туберкулёз у детей»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2029 года
Код в рубрикаторе	`507_4` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество фтизиатров; Ассоциация фтизиатров

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.